リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年11月7日（土）

第56号 朝刊

きょうの紙面 ▸ 脳卒中 × 歩行予後 ▸ 嚥下 × 脳卒中 ▸ 脳卒中 × 上肢機能 ▸ 短信 8本

■ 脳卒中 × 歩行予後

脳卒中リハ入院169人 8週後の自立歩行をAIで予測

AUC 0.84〜0.88　補正後はモデル間に差なし・外部検証なし

脳卒中でリハビリ入院した人が、8週後に自立歩行できるかを入院時の情報から予測した後ろ向き研究が、NeuroRehabilitation誌（2026年11月6日掲載）に出た。1施設で、入院時のFunctional Ambulation Category（FAC）が3以下の169人を対象にした。8週後に自立歩行していたのは50人（29.6%）だった。

予測に使ったのは、NIHSS、FMA下肢、バランス（BBS）、体幹機能（TIS）、MMSE-K、体性感覚誘発電位（SEP）の重症度、脳卒中の型の7項目。SEPが完全に消失していた人は、自立歩行できなかった群で36.1%、できた群で4.0%だった。ロジスティック回帰と5種類の機械学習を比べるとAUCは0.839〜0.884で、ニューラルネットワークが最高の0.884（95%信頼区間0.832〜0.937）だった。

ただし多重比較の補正後は、どのモデル間にも有意差はない。予測に効いたのはBBSとSEPだった。単施設の後ろ向きで外部検証がないため、予測値で訓練方針を決める段階にはない。入院時にバランスと感覚経路の情報を揃えておく意味を示す結果と読める。



入院時の情報で、8週後を見通す。

出典 NeuroRehabilitation ↗

数字で見る

169人
入院時FAC3以下の脳卒中（1施設）

29.6%
8週後に自立歩行（50人）

0.884
最高のAUC（ニューラルネット）

■ 嚥下 × 脳卒中

脳卒中後の嚥下障害 舌圧抵抗訓練を16試験で統合

脳卒中後の嚥下障害に対する舌圧抵抗フィードバック訓練を、通常の嚥下訓練と比べたランダム化試験のメタ解析。9つのデータベースから16試験・978人を集めた。嚥下機能の改善は通常訓練より多く（RR 1.23、95% 信頼区間 1.14 〜 1.32、I^2=0%）、合併症は少なかった（RR 0.28、0.14〜0.54）。

条件別では、最大舌圧の70%以下という中〜低強度で、4〜8週続けた場合に改善が大きい傾向だった。著者らは訓練条件を決めるために、高品質の多施設試験がまだ必要としている。強い負荷をかければ良いとは限らず、無理のない強度で数週間続けるのが目安になる。



出典 J Am Med Dir Assoc ↗

■ 脳卒中 × 上肢機能

発症1.7日後の手指麻痺が 退院時の上肢・ADLと関連

脳卒中の超急性期に手指の麻痺がどれだけ重いかで、退院時の上肢機能やADLを見通せるかを調べた後ろ向きコホート。急性期から亜急性期まで連続でリハを受けた2019〜2021年の473人のうち、解析できた356人（平均66.7歳）を対象に、発症後1.7日のSIAS手指機能（SIAS-FF）と約86.9日後の退院時の成績を比べた。

退院時はSIAS-FF、近位機能（SIAS-KM）、手の巧緻性（STEF）、FIMセルフケアで評価した。年齢と在院日数で調整しても、急性期のSIAS-FFが良い人ほどすべての項目で成績が良く、関連はいずれもp<0.01だった。後ろ向きの観察研究で、効果量は抄録に示されていない。



出典 Front Rehabil Sci ↗

短 信

〈制度〉韓国、専門リハ病院制度で在院日数+10%
外傷性脳損傷の全国保険DB解析。制度後に在院日数が10.0%増え、専門病院への入院OR1.36。 出典 Front Rehabil Sci ↗

〈大腿骨骨折〉骨折後ADLは6年後も25%悪い
中国の719人を9年追跡。直後に困難が増え、70〜79歳が最脆弱、80歳以上は回復中も悪化。 出典 JAMDA ↗

〈人工膝関節〉駆血は時間が長いほどMUAが増加
TKA 1.7万人の後ろ向き。全時間駆血のMUAのOR 1.64、部分駆血は増えず。単施設。 出典 J Arthroplasty ↗

〈人工膝関節〉UKA 2,234膝、15年再置換なし85%
単一施設の後ろ向き。技術支援と固定型が再置換の低さと関連。10年では92%。 出典 JBJS ↗

〈骨折〉寛骨臼骨折後の重症HOは術者要因ではない
1,292人の後ろ向き。重症HOは頭部外傷や人工呼吸など患者・外傷要因が主。 出典 Injury ↗

〈神経疾患〉MSの運動促進、教育と紹介経路が課題
専門職の認識を扱う質的研究8本の統合。専門教育・資料・紹介経路・多職種の連携が論点に。 出典 Disabil Rehabil ↗

〈測定〉下肢リンパ浮腫、体積測定が最も精密
成人51人で4法を検者間比較。Perometerなど3法はICC0.90以上、TDCは部位差が大きい。 出典 Disabil Rehab ↗

〈医療AI〉陽性ANA者の予測モデルで診断が早まる
RCT。介入群は診断までの中央値43日、対照群は138日。ハザード比1.9。単一の医療機関。 出典 NEJM AI ↗